

POLYGRAPHIE DU SOMMEIL

RAPPORT MÉDICAL D'ANALYSE VENTILATOIRE ET OXYMÉTRIQUE

Exploration polygraphique ambulatoire conforme aux critères AASM / SFRMS

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue – Allergologue
N° d'Ordre : 0535/24

☎ 0663 755 584 ✉ selma.bakha@hotmail.com
📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi (en face des urgences), Guelma

IDENTIFICATION PATIENT ET CONDITIONS DE TEST

Nom & Prénom :	MADI SALIHA	N° Enregistrement :	20260930-143
Âge :	62 ans (Née en 1962)	Date d'examen :	30 Septembre 2026
Genre :	Féminin	Créneau analysé :	22 :33 – 08 :14 (UTC+1)
Poids / Taille :	84 kg / 153 cm	Durée totale (min) :	581,0 min (9h 41min)
Indice de Masse Corp. :	35,9 kg/m ² (Obésité Cl. II)	Durée valide exploitable :	581,0 min (100,0%)



📄 Téléchargement Numérique Sécurisé du Tracé

Scannez ce QR code avec votre smartphone pour accéder à l'enregistrement intégral synchronisé (flux nasal, dynamique oxymétrique, actigraphie et canaux posturaux).

✓ Enregistrement validé techniquement : Capteurs de débit, canule nasale, oxymétrie de pouls et actimétrie positionnelle sans artéfact préjudiciable.

1. TRACÉ CHRONOLOGIQUE ET CINÉTIQUE MULTICANALE

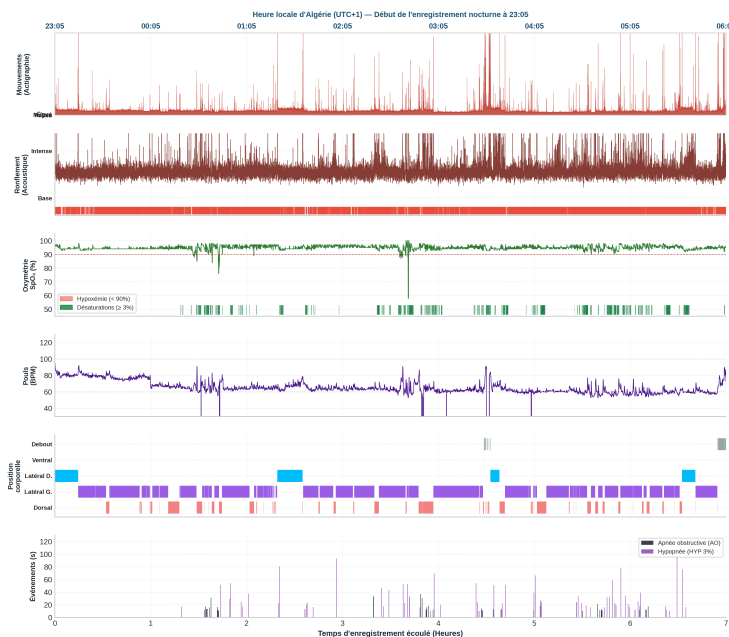


FIGURE 1 – **Tracé polygraphique continu multicanal (22 :33–08 :14, Heure locale d’Algérie UTC+1)** : Synchronisation sur 581 min (9h 41min) de l’actigraphie (mouvements), du ronflement acoustique (silencieux), de l’oxymétrie de pouls SpO₂ (nadir à 88%), de la fréquence cardiaque, de la position (cyan : Latéral D., violet : Latéral G., rouge : Dorsal) et des événements respiratoires.

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS VENTILATOIRES ET POSTURAUX

2.1. Distribution Posturale et Impact sur la Sévérité Événementielle

Position Corporelle	Durée (min)	% Temps	Hypop.	AO	AC	Désat.	IDO (/h)	Sévérité
Décubitus Dorsal (Supine)	117,6	20,2%	4	4	0	19	9,7	Léger
Décubitus Latéral Gauche	234,0	40,3%	8	2	0	10	2,6	Normal
Décubitus Latéral Droit	229,4	39,5%	4	1	0	17	4,4	Normal
Décubitus Ventral (Prone)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0,0	—
Érigée / Assise (Stand)	0,0	0,0%	0	0	0	0	0,0	—
Total / Moyenne Globale	581,0	100,0%	16	7	0	46	5,1	Limite

2.2. Caractérisation Phénotypique des Événements Ventilatoires

Nature de l’Événement	Nombre	Index (/h)	Durée Moyenne	Durée Maximale
Apnées Obstructives (AO / SAOS)	7	0,7 /h	25,3 s	93,4 s
Apnées Centrales (AC)	0	0,0 /h	—	—
Apnées Mixtes (AM)	0	0,0 /h	—	—
Hypopnées Obstructives	16	1,7 /h	15,1 s	23,5 s
Index d’Apnées-Hypopnées (IAH)	23 totaux	2,4 /h	18,2 s	93,4 s
Index de Perturbation Respiratoire (RDI)	23 totaux	2,4 /h	—	—

3. CINÉTIQUE OXYMÉTRIQUE ET TABLEAU DE BORD BIOMARQUEURS

Paramètre Oxymétrique	Valeur	Norme AASM	Interprétation Clinique
Saturation Moyenne en O ₂ (SpO ₂)	95,0 %	≥ 95,0 %	Normale à l'état basal
Saturation Maximale en O ₂	99,0 %	≥ 95,0 %	Réserve d'oxygénation conservée
Nadir Oxymétrique Événementiel	88,0 %	≥ 90,0 %	Désaturation ponctuelle modérée
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	5,1 /h	< 5,0 /h	Seuil limite / discrète réactivité
Index de Désaturation Dorsal	9,7 /h	< 5,0 /h	Réactivité posturale sur le dos
Temps passé sous 90% (T90)	0,8 min (0,1%)	< 1,0% du temps	Absence d'hypoxémie fixée
Temps passé sous 95%	186,7 min (32,3%)	–	Fluctuations péri-basales modérées
Charge Hypoxique (Hypoxic Burden)	5,4 %-min/h	< 15,0 – 20,0	Faible sur-risque cardiovasculaire

Biomarqueur Clé	Valeur	Biomarqueur Clé	Valeur
Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)	2,4 /h	Indice de Ronflement	0,1 /h (Silencieux)
Index de Désaturation (IDO)	5,1 /h	Index d'Apnées Obstructives	0,7 /h (7 au total)
Charge Hypoxique (Hypoxic Burden)	5,4 %-min/h	Fréquence Cardiaque Moyenne	75,9 bpm
SpO ₂ Minimale (Nadir)	88,0 %	Écarts FC (Min / Max)	59 / 101 bpm
Temps passé sous 90% (T90)	0,1 % (0,8 min)	Changements de position	432 transits

4. AVIS MÉDICAL INTÉGRÉ & STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

1. Analyse Ventilatoire et Physiopathologique Intégrée

- > **Index Respiratoire Physiologique (IAH = 2,4/h)** : L'enregistrement sur 581 minutes (22 :33-08 :14) confirme un **IAH normal à 2,4/h** (23 événements au total : 7 apnées obstructives, 16 hypopnées), éliminant un syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAHOS) modéré à sévère selon les critères AASM v2.6.
- > **Réactivité Posturale Dorsale Modérée** : On constate une sensibilité de la filière pharyngée en position couchée sur le dos : l'**IDO dorsal monte à 9,7/h** avec 8 événements respiratoires concentrés sur les 20,2% de la nuit passés sur le dos. En revanche, le décubitus latéral droit et gauche (79,8% du temps total) assure une excellente stabilité respiratoire ($IAH \leq 2,6/h$, $IDO \leq 4,4/h$).
- > **Seuil d'Éveil Élevé (High Arousal Threshold) & Apnée Maximale (93,4 s)** : L'enregistrement isole une apnée obstructive ponctuelle prolongée de 93,4 s avec un nadir oxymétrique à 88%, sans phénomène de répétition en cascade ni instabilité du gain de boucle ventilatoire (Low Loop Gain).
- > **Excellente Sécurité Cardiovasculaire** : Le ronflement est virtuellement absent (0,1/h), le temps sous 90% est infime ($T_{90} = 0,1\%$, soit 48 secondes) et la **charge hypoxique est très basse à 5,4 %·min/h**, écartant tout retentissement hypoxique tissulaire délétère.

2. Conclusion Diagnostique

Polygraphie ventilatoire normale sur l'index global (IAH = 2,4/h), réfutant un SAHOS constitué. Présence d'une **réactivité posturale dorsale modérée isolée (IDO dorsal = 9,7/h)** et d'une apnée maximale isolée (93,4 s, nadir 88%). Charge hypoxique faible (5,4 %·min/h) et absence d'hypoventilation alvéolaire ($T_{90} = 0,1\%$).

3. Conduite à Tenir & Recommandations Thérapeutiques

1. Conseils de Thérapie Positionnelle Préventive :

- o Privilégier le décubitus latéral (oreiller ergonomique d'évitement dorsal) afin d'annihiler la réactivité dorsale isolée (9,7/h).

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue – Allergologue

N° d'Ordre : 0535/24

Signature et cachet :